Sơ Cấp Cứu

Các tai nạn do khí gây ra

SƠ CẤP CỨU LÀ GÌ?

Là hành động trợ giúp người bệnh bất thường hay người bị tai nạn khi chưa có mặt của nhân viên y tế nhằm mục đích:

- Bảo toàn tính mạng cho người bệnh hay nạn nhân.
- Bảo vệ các vết thương hoặc bệnh không cho nặng thêm.
- Tạo điều kiện cho nạn nhân phục hồi.

LÀM GÌ TRONG SƠ CẤP CỨU?

- 1. Quan sát hiện trường nhằm:
  - Thu thập thông tin
  - Đảm bảo hiện trường an toàn
- 2. Gọi sự trợ giúp
- 3. Tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân
- 4. Đánh giá, phân loại.
- 5. Trợ giúp, chăm sóc người bị nạn (bệnh)
- 6. Vận chuyển an toàn

Nguyên tắc trong sơ cứu ban đầu

Bình tĩnh: *Dù trong bất cứ tình huống nào, bạn cần cố gắng bình tĩnh*

An toàn: *Ai là người giúp đỡ nạn nhân*

Ngay lập tức: *Bạn làm một điều gì đó luôn tốt hơn là không làm gì cả*

Nhanh chóng: *Thời gian là cuộc sống*

Chính xác: *Tính mạng con người đang nằm trong tay bạn*

Theo dõi: *Không ai học được chữ ngờ*

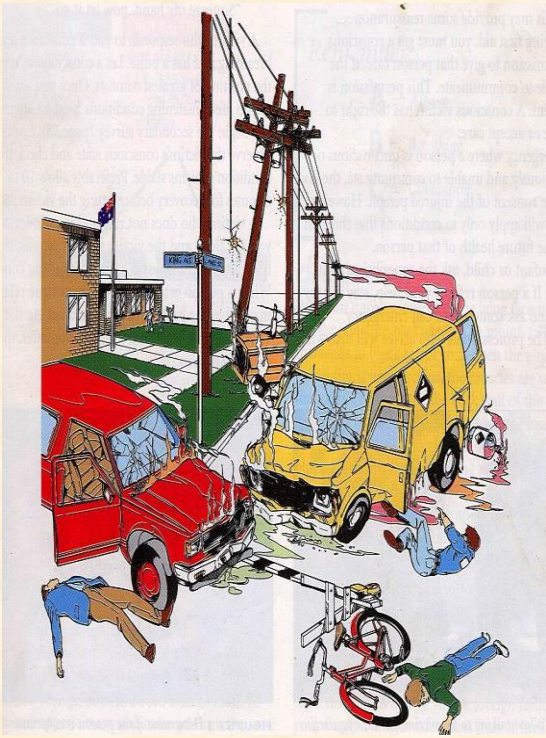
THỨ TỰ HÀNH ĐỘNG

Ứng phó

các trường hợp khẩn cấp

1. QUAN SÁT HIỆN TRƯỜNG

- Để làm gì?
- Biết việc gì đã, đang và sắp xảy ra?
- Mức độ khẩn cấp?
- Điều kiện an toàn?
- Có bao nhiêu người bị nạn?
- Ai có thể trợ giúp?



2. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG NẠN NHÂN

Các dấu hiệu sống còn quan trọng

- **R**esponse: Phản ứng
  (Cử động +Ý thức)
- Airway+Breathing: Hô hấp
  Airway: Đường thở
  Breath : Hơi thở
- **C**irulation: Tuần hoàn tim mạch
  Mạch - Tim

Các dấu hiệu sống còn thứ cấp

- Thân nhiệt
- Màu da
- Đồng tử
- Cảm giác đau
- Liệt
- Nôn, mửa
- Co giật

3. GỌI SỰ TRỢ GIÚP

<u>Gọi điện thoại:</u>

- ✓ **113 – Cảnh sát**
- ✓ **114 – Cứu hoả**
- ✓ **115 – Cấp cứu**

➡ **Hô to để mọi người đến giúp**

4. THỰC HIỆN SƠ CỨU VÀ VẬN CHUYỂN

- Hồi sức tim phổi
- Cầm máu
- Cố định xương gãy
- Băng vết thương
- Vận chuyển nạn nhân an toàn

NGUYÊN TẮC NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN

- An toàn cho bạn, nạn nhân và những người xung quanh.
- Không di chuyển nạn nhân khi chưa được sơ cấp cứu
- Bình tĩnh và luôn luôn cần sự trợ giúp.
- Hành động thống nhất.
- Tránh những hành động không cần thiết.

NGUYÊN TẮC (tt)

- Đeo găng tay hoặc sử dụng túi nilon khi tiếp xúc với vết thương.
- Rửa tay trước và sau khi sơ cứu.
- Xử lý các vật dụng sau khi sơ cứu (Đốt, chôn những băng gạc dính máu, rửa sạch dụng cụ.

Di chuyển nạn nhân khẩn cấp

Được thực hiện khi:

- Hiện trường nguy hiểm.
- Tác nhân có đe doạ đến tính mạng phải được di chuyển.
- Nạn nhân phải được di chuyển đến một vị trí thích hợp.

Di chuyển nạn nhân khẩn cấp

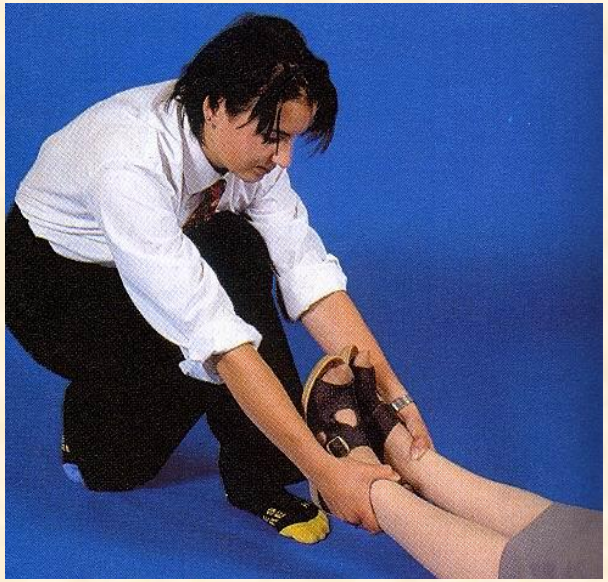
PP nắm 2 cổ tay

- Nạn nhân nằm ngửa.
- Người sơ cấp cứu đứng phía trên đầu nạn nhân, hai chân dang rộng bằng vai.
- Nắm hai cổ tay nạn nhân.
- Nhấc nạn nhân theo phương thẳng đứng, kéo ra khỏi nơi nguy hiểm.

Di chuyển nạn nhân khẩn cấp

- Nạn nhân nằm ngửa.
- Sửa tay nạn nhân xuôi song song trên phía đầu, hoặc xếp trên bụng.
- Người sơ cấp cứu đứng ở phía chân nạn nhân.
- Nắm 2 cổ chân nạn nhân, kéo ra khỏi nơi nguy hiểm.
- Có một người hỗ trợ ở đầu tránh gây tổn thương.
- Khi kéo cần chú ý giữ đầu và cột sống nạn nhân trên đường thẳng.

PP nắm 2 cổ chân



Di chuyển nạn nhân khẩn cấp
Phương pháp ôm vai sốc nách

Một người

Hai người

Di chuyển nạn nhân khẩn cấp

Kéo nạn nhân bằng vải

Di chuyển nạn nhân khẩn cấp

Cõng nạn nhân trên lưng

Tai nạn, thương tích

“Tai nạn” là một sự kiện bất ngờ xảy ra, không có nguyên nhân rõ ràng và khó lường trước được.

“Thương tích” là những thương tổn thực thể trên cơ thể người do tiếp xúc cấp tính với các nguồn năng lượng hoặc tác động lực từ một vật.

Thời gian tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ dẫn đến thương tích thường rất ngắn (vài phút).

Các tổn thương có thể xảy ra khi:

Xảy ra sự cố trong lao động, sản xuất, kinh doanh Gas LPG, những người có mặt tại hiện trường nếu không được trang bị các thiết bị bảo hộ, hoặc các trang thiết bị an toàn không đảm bảo thì nguy cơ ảnh hưởng đến cơ thể là rất lớn.

Những tổn thương đó có thể từ nhẹ tới nặng, từ trực tiếp đến gián tiếp.

TỔN THƯƠNG MẮT

Triệu chứng:

- Mắt bị tổn thương: Sưng, chảy nước mắt, phỏng, có thể nhìn không rõ hoặc không nhìn thấy.

Xử trí:

- Loại bỏ nguy hiểm khỏi mắt bằng nước sạch.
- Không bôi bất cứ loại thuốc nào lên mắt.
- Dùng nước sạch làm mát liên tục và chuyển viện.

TỔN THƯƠNG DO BỎNG

1. TỔN THƯƠNG DO BỎNG LẠNH:

- Bỏng lạnh là tình trạng mô sống ở người bị đông cứng và bị tổn thương do tiếp xúc với nhiệt độ quá thấp. Bỏng lạnh thường gặp ở bàn tay, bàn chân, mũi và tai.
- Bỏng lạnh có thể là một loại vết thương rất nghiêm trọng. Các mô có thể mất nhiều tuần để hồi phục. Bệnh nhân có thể mất da, ngón tay, ngón chân cũng như bị dị tật và đổi màu. Những người bị bỏng lạnh còn có thể bị hạ thân nhiệt.

Vd: Bị bỏng do tiếp xúc với đá lạnh; khí nén, khí hóa lỏng bị làm lạnh (LPG, LNG, CNG, khí Hydro, khí Nitơ, khí Amoniac...); vật dụng kim loại bị làm lạnh...

CÁC BƯỚC CHĂM SÓC BỎNG LẠNH:

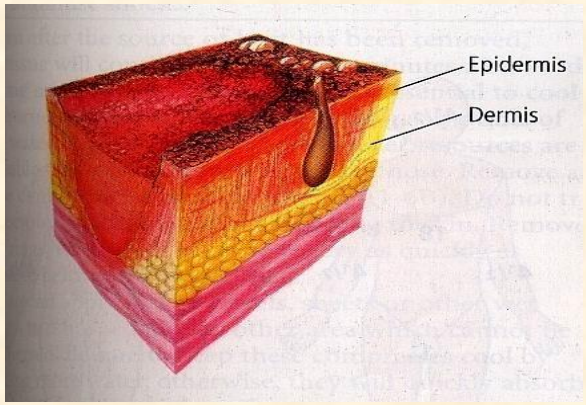
- Đưa người bệnh đến nhưng nơi ấm áp càng nhanh càng tốt để tránh thân nhiệt tiếp tục bị hạ.

- Hãy làm ấm hay ngâm các vùng bị tổn thương trong nước ấm từ 40 đến 42 độ C để làm ấm vùng tổn thương trong thời gian từ 10 đến 20 phút tùy theo mức độ bỏng.

- Cuối cùng hãy chuyển bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất để được bác sĩ chuyên khoa khám và điều trị.

TỔN THƯƠNG DO BỎNG

2. TỔN THƯƠNG DO BỎNG NÓNG:



- **Bỏng nhiệt:**

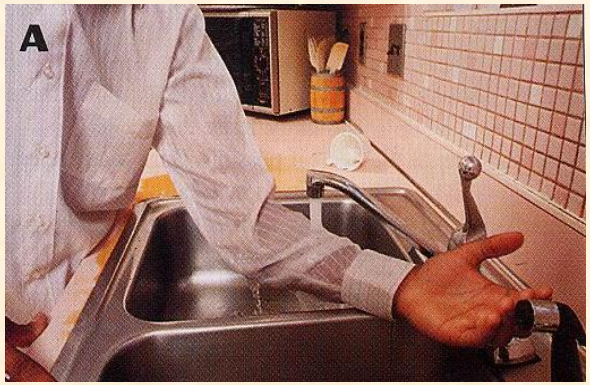
- Nhiệt khô : bàn là, bô xe máy, cháy nổ bình ga, hoả hoạn,...

- Nhiệt ướt : bỏng nước sôi, canh sôi, hơi nước nóng,...

- **Bỏng điện:** điện sinh họat, điện công nghiệp.
- **Bỏng hoá chất:** các loại dung môi công nghiệp, axit, bazơ mạnh (H_2SO_4, HCl, NaOH...), khí dầu mỏ LPG, khí thiên nhiên LNG, CNG, Xăng dầu ....
- **Bỏng do tia bức xạ**: trong công nghiệp.

CÁC BƯỚC CHĂM SÓC BỎNG NÓNG:

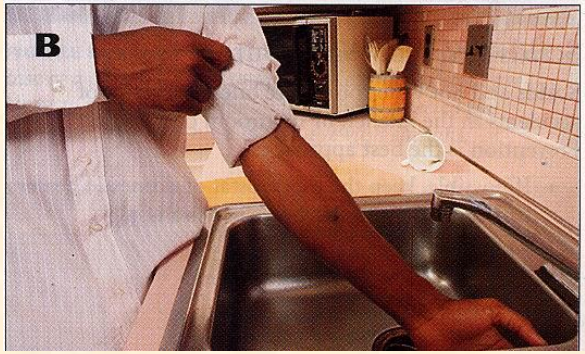
- Làm lạnh vùng phỏng
- Phủ kín vùng phỏng
- Ngăn ngừa nhiễm trùng
- Giảm đến mức thấp nhất shock



<u>Lưu ý:</u>

✓ *Cần nhanh chóng cởi bỏ quần áo, nhẫn, đồng hồ, trang sức trước khi vùng phỏng bị sưng phù.*

✓ *Không cố gắng lột bỏ quần áo bị dính vào da khi phỏng.*



CÁC BƯỚC CHĂM SÓC BỎNG NÓNG:

- **Làm lạnh:** *Bất cứ nguồn gì được cung cấp, hoặc có thể ngâm vào nước lạnh cho đến khi bờ vết bỏng không còn ấm.*
- **Phủ kín:** *Dùng vải, quần áo không có sợi bông – giúp ngăn ngừa nhiễm trùng – băng lỏng nếu cần.*
- **Ngăn ngừa nhiễm trùng:** *Không chạm vào vết phỏng, không làm vỡ hoặc rách chỗ giộp da, không bôi bất kỳ thuốc mở, dầu hay áp dụng các biện pháp nào khác khi chưa được hướng dẫn của chuyên môn – chăm sóc như vết thương hở.*
- **Giảm tối thiểu shock (sốc):** *Giảm đau và bù dịch mất – phủ kín gió và cho nạn nhân uống ORS.*

  Chú ý: *Nạn nhân cần được giữ thân nhiệt và nâng cao vùng bỏng trên khỏi tim để giảm đau nếu có thể.*

Khi chăm sóc bỏng cần chú ý

Nên làm

- Làm lạnh hoặc ấm chỗ bỏng bằng vòi nước chảy.
- Cởi tháo nhẫn và đồ trang sức.
- Phủ vùng phỏng bằng vải khô, sạch.
- Thực hiện các bước giảm shock (sốc).

Không nên làm

- Chườm lạnh trực tiếp lên chỗ bỏng.
- Chạm vào vết bỏng với bất kỳ cái gì trừ vải khô, sạch; không kéo giật quần áo trên vùng bỏng.
- Lấy các mẫu quần áo dính trên vùng bỏng.
- Cố gắng làm sạch vết bỏng cháy.
- Làm vỡ chỗ giộp da.
- Dùng mỡ, dầu... Bôi lên vùng bỏng.
- Sử dụng vải sợi hoặc bông phủ trên vết bỏng.

Chăm sóc trường hợp bỏng đặc biệt

Chăm sóc:

- Bảo đảm hiện trường an toàn.
- Gọi xe cứu thương.
- Kiểm tra và hồi phục ABC.
- Tìm vị trí phỏng.
- Chăm sóc vết phỏng.
- Che phủ bằng vải sạch.
- Chăm sóc chống sốc.

SƠ CẤP CỨU SỰ CỐ CHOÁNG

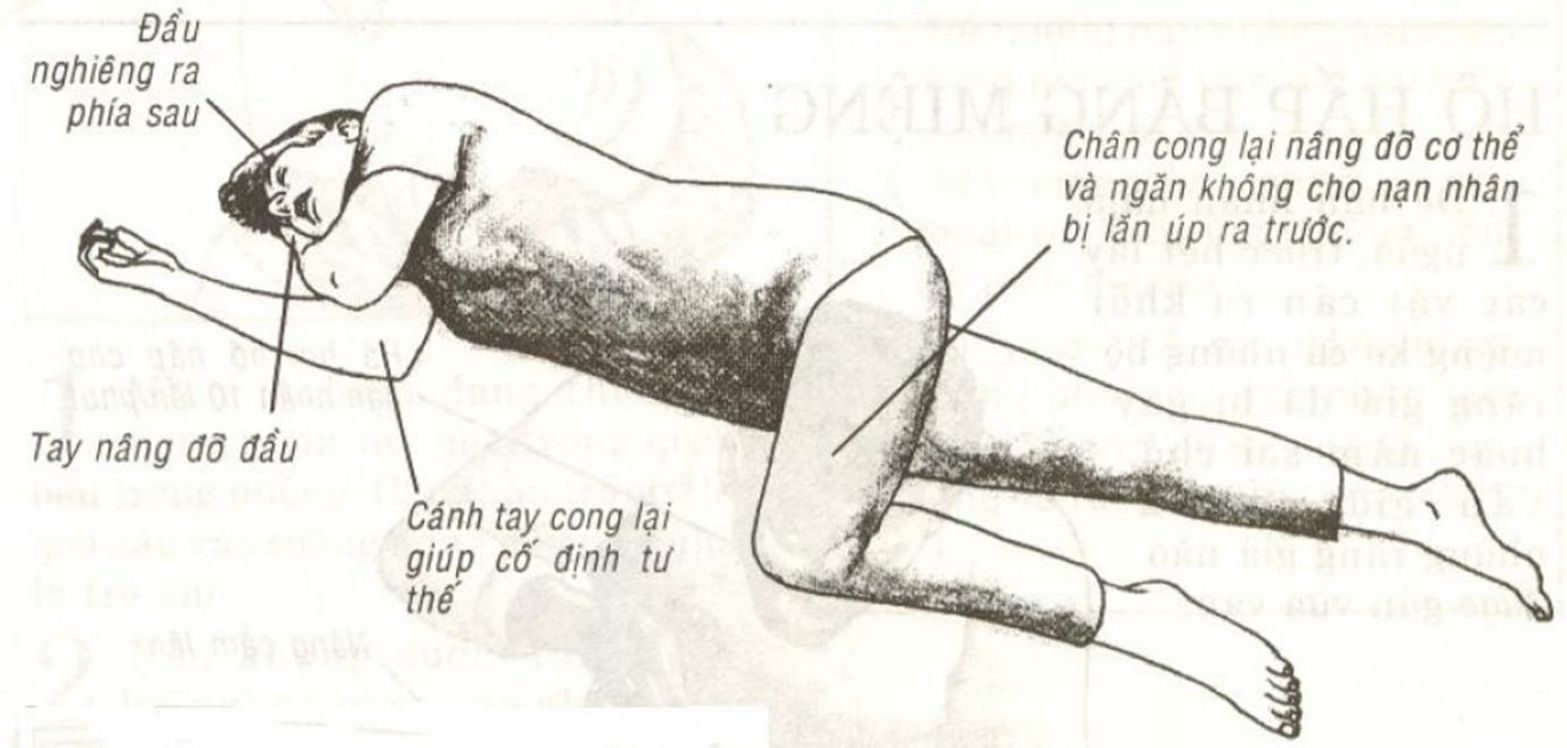
1. Đưa nạn nhân đến nơi thoáng, an toàn

2. Kê chân nạn nhân cao hơn đầu

3. Ngửa cổ, khai thông đường thở cho nạn nhân

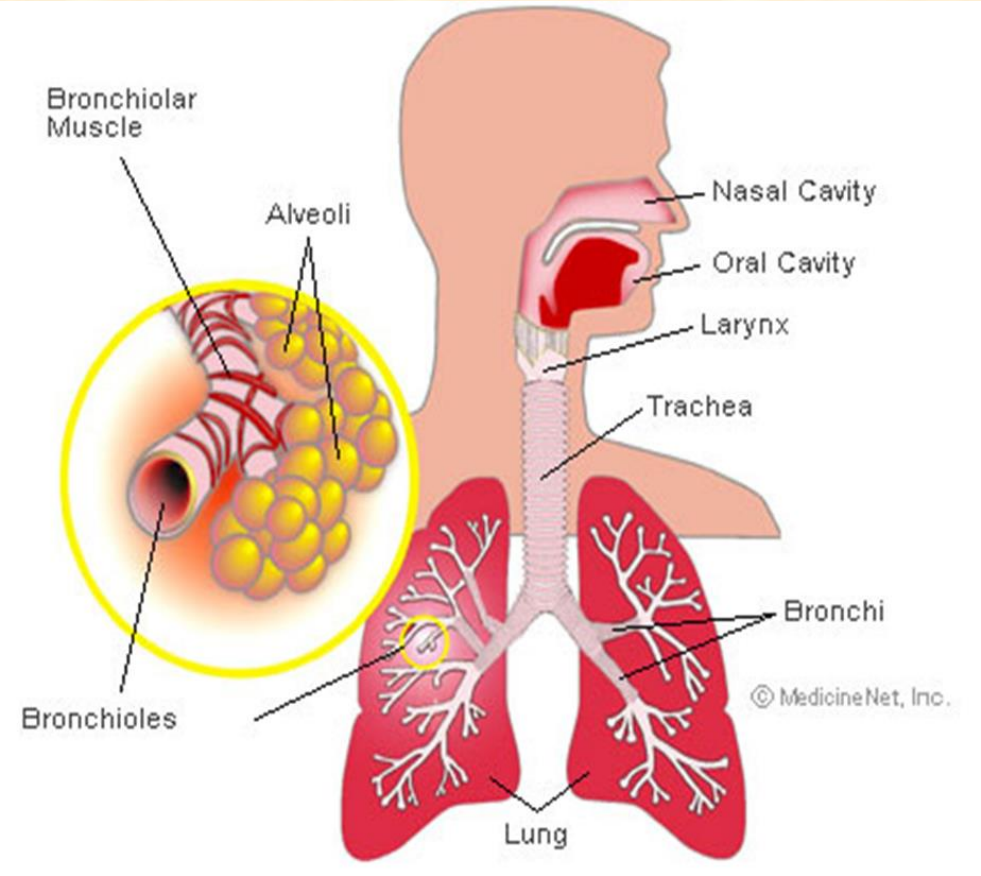
4. Nới rộng áo, quần cho nạn nhân

5. Khi nạn nhân hồi tỉnh, đặt nạn nhân về tư thế hồi phục, cho nạn nhân uống nước trà đường



SƠ CẤP CỨU BẤT TỈNH

HỒI SỨC TIM PHỔI - CPR
(Cardiac pulmonary resuscitation)



Kiểm tra nhận thức (R = Response)

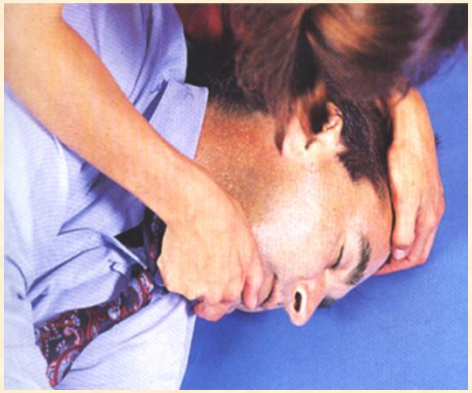
- Lay và gọi nạn nhân
- Ra một lệnh đơn giản

➡Để kiểm tra mức độ nhận thức và phản ứng của nạn nhân

Kiểm tra và làm thông đường thở (A= Airway)

- Một bàn tay giữ ở trán.
- Một bàn tay kia đỡ ở cằm.
- Giữ mặt nạn nhân và nâng nhẹ đầu nạn nhân về phía sau.

Kiểm tra và làm thông đường thở (A= Airway)



- ***Làm sạch đường thở:***
- Mở miệng nạn nhân.
- Dùng ngón tay lấy hết ngoại vật trong miệng nạn nhân ra.

Kiểm tra hô hấp
(B = Breathing)

- Nhìn (Look)
- Sờ (Touch)
- Nghe (Listen)
- Cảm nhận (Feel)

Thực hiện từ 5 – 10 giây

Kiểm tra tuần hoàn (C = Cirulation)

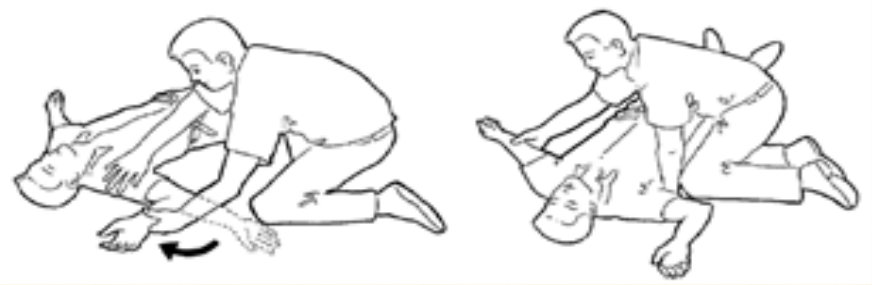
❖ ***Đối với người lớn***

- Xác định đúng vị trí động mạch ở cổ.
- Dùng 3 ngón trỏ, giữa và ngón nhẫn để cảm nhận mạch .

Đưa về tư thế hồi phục

- Đưa nạn nhân về tư thế nằm nghiêng an toàn nếu nạn nhân còn thở.
- Nếu không thở thì sơ cứu như trường hợp bất tỉnh ngừng thở.

Kỹ thuật đưa nạn nhân về tư thế nằm nghiêng an toàn



Hồi sức tim phổi

Mạch không xuất hiện → ngừng tim

- Xác định vị trí ép tim.
- Đặt gốc bàn tay lên vị trí ½ xương ức dưới.
- Ép tim 30 lần + 2 lần thổi
- Thực hiện 5 chu kỳ kiểm tra lại mạch và nhịp thở.
- Kiểm tra lại sau mỗi 2 phút.

Khi nào dừng CPR

- **Dấu hiệu tốt:**
  - Mặt hồng hào trở lại; Môi đỏ.
  - Xuất hiện mạch; Xuất hiện hơi thở; có tiếng khóc.
  - Cơ thể cử động; Nhận thức và phản ứng được hồi phục.
  - Có phản xạ đồng tử; Xuất hiện mạch.
  - Đưa về tư thế hồi phục; Tiếp tục theo dõi ABC.
  - Chăm sóc nạn nhân cho đến khi nhân viên y tế hoặc xe cấp cứu đến.

Khi nào dừng CPR

- **Dấu hiệu xấu:**
  - Tiếp tục tím tái; Mạch vẫn không đập hoặc yếu dần rồi mất.
  - Không có hô hấp; Vẫn bất động không có phản ứng.
  - Đồng tử giản; Xác định tiếp các dấu hiệu của sự sống.
  - Tiếp tục CPR cho đến khi nhân viên y tế hoặc xe cấp cứu đến.
  - Cung cấp thông tin cần thiết cho cơ quan hữu quan nếu nạn nhân chết.

Trân trọng cảm ơn!